Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO PERFURATIVO

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! Apesar de não serem tão frequentes questões sobre abdome agudo perfurativo, elas não costumam ser muito difíceis. Então, leia com atenção este resumo e visualize bem as imagens, elas são fundamentais para o diagnóstico de uma perfuração intestinal. Coloquei neste resumo o que você realmente precisa saber sobre o tema. Mas não se esqueça de que nosso livro texto está mais completo e detalhado.

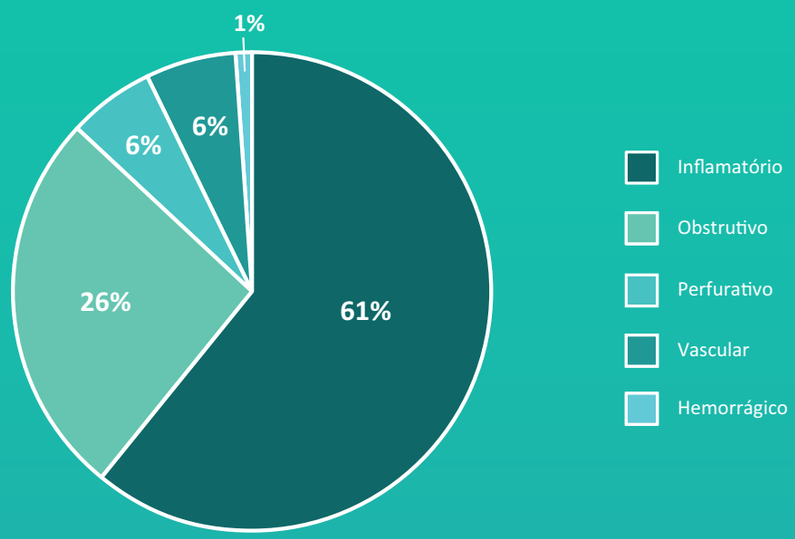
Estratégia MED
@prof.renathapaiva
@estrategiamed
@estrategiamed
t.me/estrategiamed
/estrategiamed

Estratégia MED

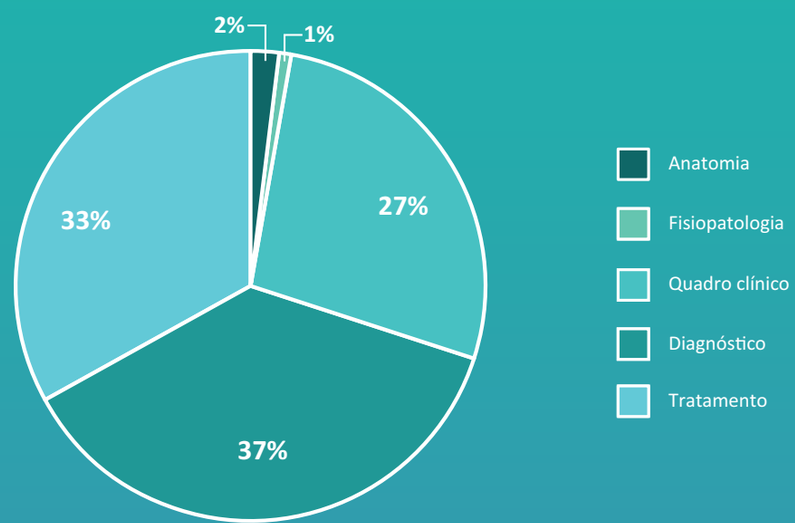
Medicina livre, venda proibida. Twitter @Livremedicina

Veja, nos gráficos a seguir, como é cobrado o tema abdome agudo perfurativo nas provas de Residência Médica:

ABDOME AGUDO



ABDOME AGUDO PERFURATIVO



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 5
2.0 ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA 5
2.1 EPIDEMIOLOGIA 5
2.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 6
2.3 LABORATÓRIO 7
2.4 EXAMES DE IMAGEM 7
2.5 TRATAMENTO 9
3.0 OUTRAS CAUSAS DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO 15
4.0 OUTRAS CAUSAS DE PNEUMOPERITÔNIO 16
5.0 LISTA DE QUESTÕES 17
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

O abdome agudo perfurativo é definido como a presença de perfuração da espessura total da parede de uma víscera oca do trato gastrointestinal, com consequente extravasamento do seu conteúdo (gás, secreção gástrica, biliosa, entérica, fecaloide) para a cavidade peritoneal ou retroperitoneal. Então, podemos ter perfuração desde o esôfago até o reto, com as mais diversas causas, como: iatrogênicas, durante a realização de exames (CPRE, colonoscopia, endoscopia); úlceras pépticas (mais comum); perfuração por corpo estranho, devido à obstrução intestinal por neoplasias, consequente a um abdome agudo inflamatório (apendicite, diverticulite) ou isquêmico.

CAPÍTULO
2.0 ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA

A causa mais comum do abdome agudo perfurativo é a úlcera péptica perfurada.

2.1 EPIDEMIOLOGIA

Principais fatores de risco:

- ✓ **infecção por *Helicobacter pylori*;**
- ✓ uso de anti-inflamatórios não esteroides (**AINE**) ou do ácido acetil salicílico (AAS);
- ✓ tabagismo;
- ✓ ingestão de etanol.

A doença ulcerosa péptica é mais comum em homens, sendo as úlceras duodenais mais frequentes do que as gástricas. Dentre as possíveis complicações da úlcera péptica, a perfuração é a segunda mais frequente (a primeira é o sangramento) e que apresenta maior taxa de mortalidade, podendo chegar a 15%.

As úlceras da parede anterior do bulbo duodenal (1ª porção) são as responsáveis pela maioria das perfurações, seguidas pelas úlceras pré-pilóricas.



AS ÚLCERAS QUE MAIS PERFURAM SÃO AS DA **PAREDE ANTERIOR** DO BULBO DUODENAL.
AS ÚLCERAS QUE MAIS SANGRAM SÃO AS DA PAREDE POSTERIOR DO BULBO DUODENAL.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

O quadro clínico clássico da úlcera péptica perfurada é **dor abdominal de início súbito, de forte intensidade**, na região epigástrica, que geralmente se irradia para todo o abdome. Pode apresentar náuseas, vômitos e sinais sistêmicos, como taquicardia, taquipneia e hipotensão arterial. É comum o paciente dar a hora exata que ocorreu a perfuração.

Ao exame físico, percebemos um paciente quieto, imóvel, pois a movimentação piora a dor. O **abdome é tenso, "em tábua", com contração muscular involuntária, descompressão brusca localizada ou difusa**, devido à irritação peritoneal. À percussão abdominal, pode ser encontrado o **sinal de Jobert**, que é a presença de timpanismo ao invés da macicez hepática habitual, devido ao pneumoperitônio. Os ruídos hidroaéreos geralmente estão diminuídos.



SINAL DE JOBERT

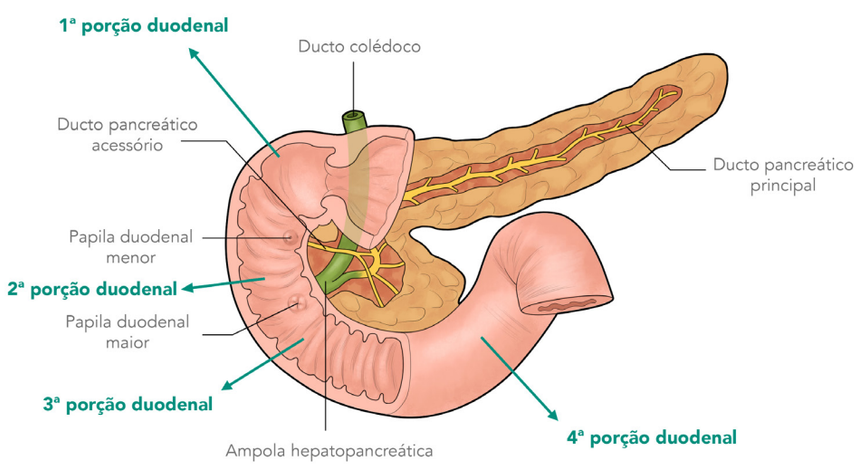
PRESENÇA DE TIMPANISMO AO INVÉS DA MACICEZ NA LOJA HEPÁTICA

=

PNEUMOPERITÔNIO

Se a perfuração for bloqueada ou retroperitoneal, os sintomas são menos intensos quando comparados às perfurações intraperitoneais livres. Por exemplo, na perfuração duodenal retroperitoneal (2ª, 3ª e 4ª porção), o paciente pode não apresentar dor abdominal intensa e sinais de peritonite, e iniciar o quadro clínico com dor em região dorsal. Além disso, na perfuração de víscera oca retroperitoneal, podemos encontrar crepitação em fundo de saco posterior ao exame de toque retal. Vamos recordar as quatro porções do duodeno:

- ✓ 1ª porção: parte superior -> intraperitoneal (flexura duodenal superior).
- ✓ 2ª porção: parte descendente -> retroperitoneal (flexura duodenal inferior).
- ✓ 3ª porção: parte horizontal -> retroperitoneal.
- ✓ 4 ª porção: parte ascendente ->retroperitoneal (flexura duodenojejunal).



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.3 LABORATÓRIO

- ✓ Leucocitose com desvio à esquerda e aumento da PCR: a depender do tempo de evolução.
- ✓ Aumento da amilase (não tão marcante como na pancreatite).

2.4 EXAMES DE IMAGEM

ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

Primeiro exame de imagem a ser solicitado na suspeita de um abdome agudo perfurativo, em que podemos visualizar o **PNEUMOPERITÔNIO** em até 75% das úlceras pépticas perfuradas.

Vamos recordar as incidências da rotina radiológica do abdome agudo:



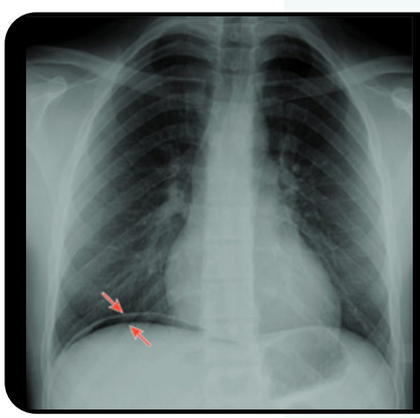
ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) em pé (ortostase).

Radiografia de abdome anteroposterior (AP) em pé e deitado (decúbito dorsal).

Em pacientes que não conseguem ficar de pé, podemos realizar a radiografia de abdome em decúbito lateral com raios horizontais.

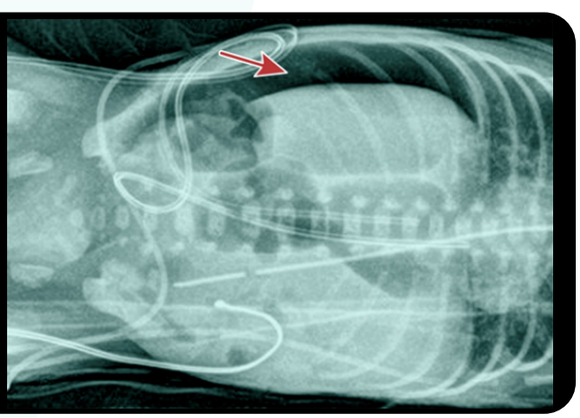
Mas preste atenção: a ausência de pneumoperitônio não exclui o diagnóstico de abdome agudo perfurativo!



Pneumoperitônio.



Pneumoperitônio volumoso.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



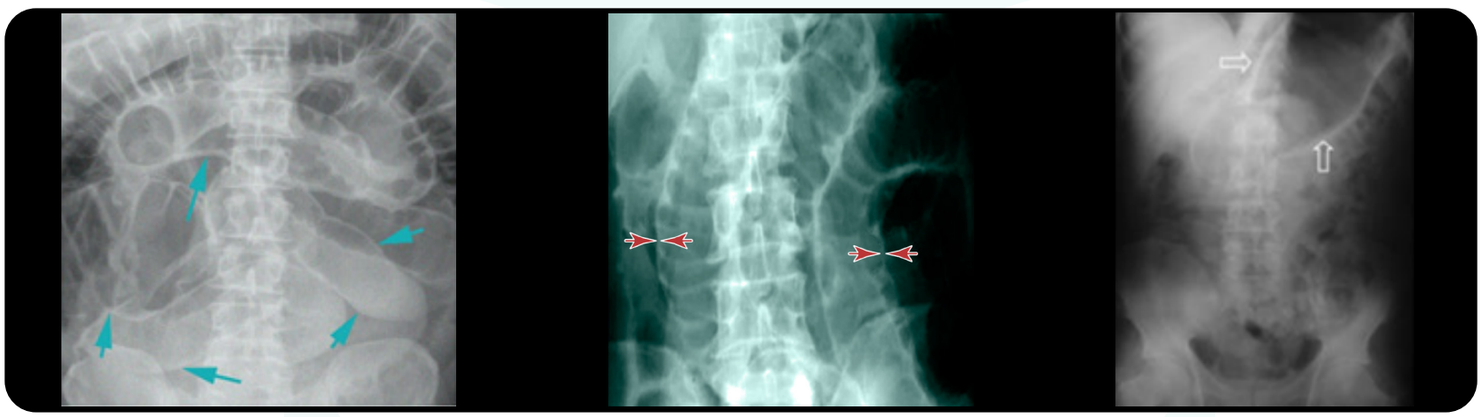
Pneumoperitônio: incidência com raios horizontais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



SINAL DE RIGLER

Também conhecido como "sinal da dupla parede". É um sinal radiológico que se refere à visualização, na radiografia de abdome, da parede gástrica ou intestinal (superfície interna e externa) devido à presença de gás na cavidade abdominal (pneumoperitônio).



Sinal de Rigler.

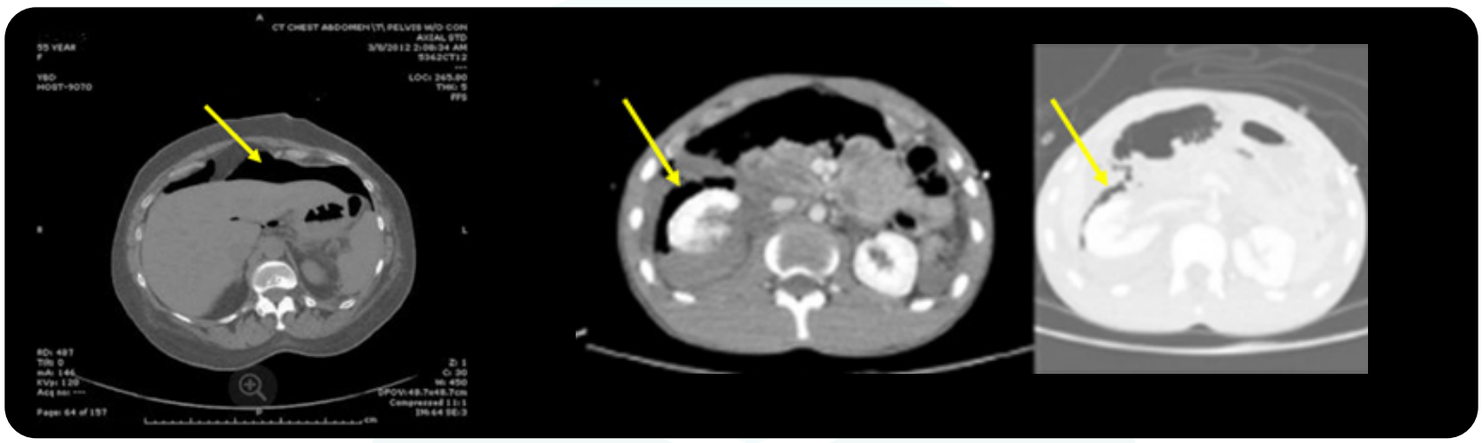
Sinal de Rigler ou sinal da dupla parede.
Fonte: Prova de acesso direto HIAE 2020

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A TC é considerada o **melhor exame para o diagnóstico do abdome agudo perfurativo**, pois pode demonstrar quantidades menores de ar intracavitário. Além do pneumoperitônio, a tomografia identifica bem um retropneumoperitônio e é possível visualizar complicações associadas à perfuração, como abscesso intra-abdominal ou formação de fístula gastrointestinal. Mas, preste atenção: o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de uma perfuração intestinal é rotina radiológica de abdome agudo, a tomografia fica reservada para os casos em que o pneumoperitônio não for visualizado na radiografia simples.

Devemos lembrar-nos de que a maior parte do duodeno é retroperitoneal (2ª, 3ª e 4ª porção). Dessa forma, perfurações nessas regiões podem apresentar retropneumoperitônio, que é melhor visualizado na tomografia, mas pode, ocasionalmente, ser identificado na radiografia simples de abdome.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



TC: Pneumoperitônio.
Fonte: Prova de acesso direto UFRN 2021.

TC: retropneumoperitônio.
Fonte: Prova de acesso direto USP SP 2021.

ULTRASSONOGRAFIA

Não é o melhor exame para identificar o pneumoperitônio, além de ser examinador dependente.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

NÃO DEVE ser realizada na suspeita de uma perfuração de úlcera péptica, pois a insuflação de ar pode "destamponar" uma úlcera perfurada e bloqueada.

RADIOGRAFIA CONTRASTADA

Os exames contrastados, principalmente com o uso do bário, devem ser evitados, pois o bário pode causar uma peritonite química, altamente letal. Se for indicado um exame contrastado, este deve ser feito com contraste hidrossolúvel, pois, caso ocorra desbloqueio da perfuração, é muito menos pernicioso do que o bário.

2.5 TRATAMENTO

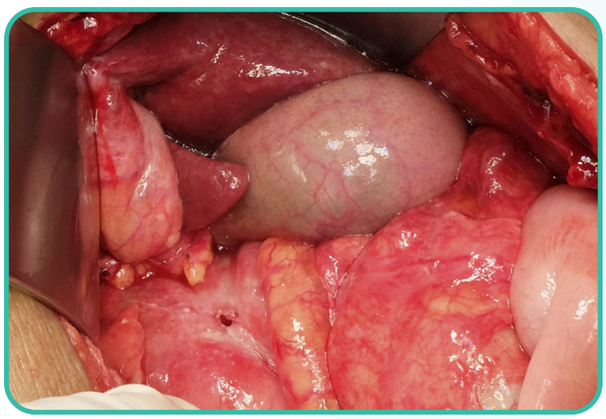
O tratamento da úlcera péptica perfurada é **CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA**! É comum os pacientes já se apresentarem com repercussão hemodinâmica e choque séptico. Por esse motivo, é **primordial a reanimação antes da cirurgia**, de forma rápida e contínua, que consiste em reanimação volêmica com cristaloide, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos (se presentes), analgesia, iniciar antibióticos de largo espectro e, se necessário, drogas vasoativas.

A via de acesso cirúrgico é feita por **laparotomia ou por laparoscopia** (desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente). A cirurgia a ser realizada dependerá da localização, tamanho da úlcera, tempo de evolução e, principalmente, das condições clínicas do paciente. Abordaremos cada uma dessas situações e suas respectivas condutas.

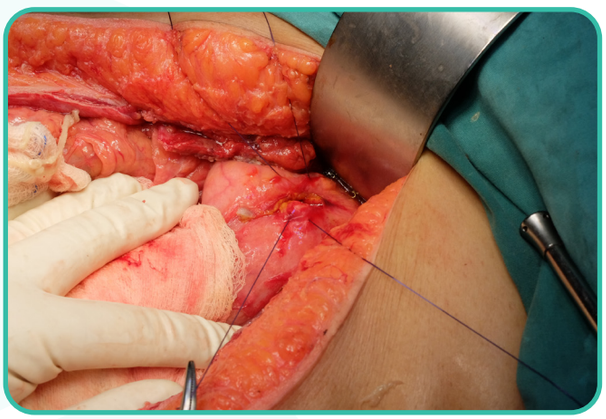
1. PACIENTES INSTÁVEIS, COM PERFURAÇÃO > 24 HORAS, PERITONITE DIFUSA E ALTO RISCO CIRÚRGICO

✓ Ulcerorrafia e epiploplastia (*patch* de omento ou *patch* de Graham) + lavagem da cavidade. As bordas das úlceras gástricas devem ser ressecadas ou ao menos biopsiadas (para descartar neoplasia). É importante fazer o tratamento do *H. Pylori* se for positivo (realizar EDA geralmente após 4 semanas de pós-operatório).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

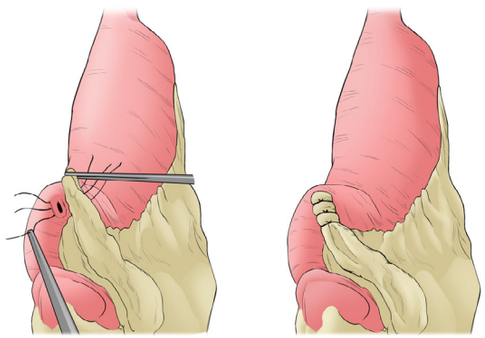


Úlcera gástrica pré-pilórica perfurada.
Fonte: Shutterstock.



Ulcerorrafia.
Fonte: Shutterstock.

Patch de Graham



TÉCNICA DO *PATCH* DE GRAHAM

Múltiplos pontos de sutura pegando tecido saudável próximo às bordas proximal e distal da úlcera são confeccionados.

O omento é posicionado por baixo desses pontos, que são amarrados, fixando-o sobre a lesão e selando a perfuração.

2. PACIENTES ESTÁVEIS, COM PERFURAÇÃO < 24 HORAS, SEM PERITONITE DIFUSA E BAIXO RISCO CIRÚRGICO

PARA ÚLCERAS DUODENAIS (HIPERCLORIDRIA)

De um modo geral, a perfuração está localizada na parede anterior do bulbo duodenal e apresenta menos de 5 mm de diâmetro. O simples fechamento com *patch* de omento e irrigação da cavidade com soro fisiológico compõe o tratamento satisfatório na maioria dos pacientes. A cirurgia definitiva para tratamento de úlceras duodenais perfuradas, a vagotomia troncular acompanhada de drenagem gástrica, é provavelmente desnecessária em muitos casos, mas sua realização deve ser considerada em pacientes que claramente não aderiram ao tratamento médico ou que apresentam histórico documentado de úlcera duodenal crônica significativa.

Nesses casos, além da rafia ou ressecção da úlcera, deve ser feita a cirurgia definitiva para o tratamento da úlcera péptica duodenal, visando reduzir a secreção ácida e, portanto, diminuir a taxa de recorrência. E como reduzir a secreção gástrica? Através da vagotomia, associada ou não à antrectomia. Veja a explicação:

Vagotomia = o nervo vago inerva o fundo gástrico, estimulando a produção de ácido pelas células parietais do corpo e fundo gástrico, e também faz a inervação parassimpática de todo o estômago e no piloro. Dessa forma, ele é responsável pelo relaxamento do piloro, permitindo a passagem do alimento do estômago para o duodeno. Uma vez feita a vagotomia troncular, o piloro fica contraído, dificultando o esvaziamento gástrico e produzindo estase gástrica. Por esse motivo, a vagotomia troncular sempre deve ser associada a um procedimento de drenagem gástrica (**piloroplastia ou antrectomia**).

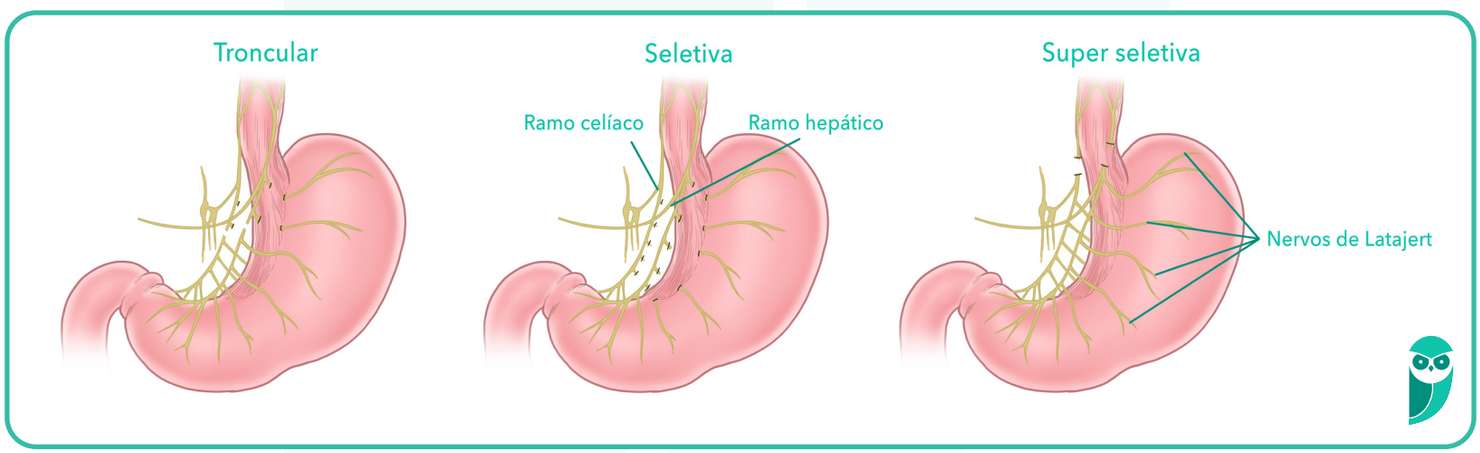
Antrectomia = retirada do antro e, consequentemente, das

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

células G produtoras de gastrina, diminuindo o estímulo à secreção ácida. É mais utilizada para o tratamento das úlceras gástricas. A reconstrução pode ser feita a Billroth I (gastroduodenostomia), Billroth II (gastrojejunostomia) e Y de Roux. A vagotomia troncular isolada reduz o pico de secreção ácida em 50% e a vagotomia associada à antrectomia diminui em aproximadamente 85%, tendo um menor índice de recorrência, porém maior morbidade e complicações pós-operatórias, como as síndromes pós-gastrectomias e pós-vagotomia.

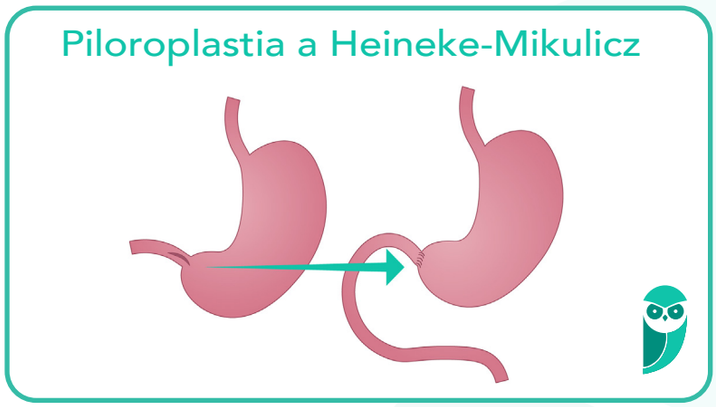
Existem três opções cirúrgicas para a vagotomia:

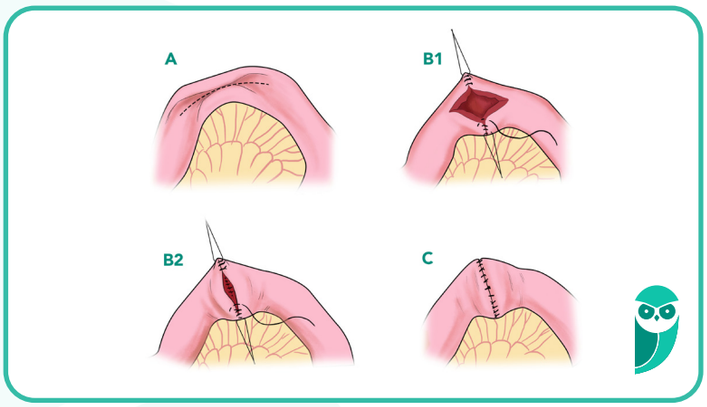
VAGOTOMIA	NERVOS SECCIONADOS	NECESSIDADE DE DRENAGEM GÁSTRICA	USO NA PRÁTICA
Troncular	Nervos vagos direito e esquerdo, acima dos ramos hepático e celíaco	Sim	Mais utilizada (menor taxa de recidiva, maior morbidade e complicações pós-operatórias)
Seletiva	Nervos vagos direito e esquerdo, logo abaixo dos ramos celíaco e hepático	Sim	Em desuso (alta taxa de recidiva)
Superseletiva	Ramificações nervosas que inervam o fundo e o corpo gástrico (nervos de Latarjet), preservando a inervação vagal do antro e piloro	Não	Pouco utilizada (trabalhosa e alta taxa de recidiva)



E, para promover a drenagem gástrica, que deve ser realizada após a vagotomia, existem várias técnicas cirúrgicas, sendo a mais utilizada a piloroplastia a Heineke-Mikulicz. Essa técnica consiste na abertura longitudinal e fechamento transversal do piloro, com o intuito de aumentar seu diâmetro.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina





Técnica de Heineke-Mikulicz: abre longitudinal e fecha transversal.

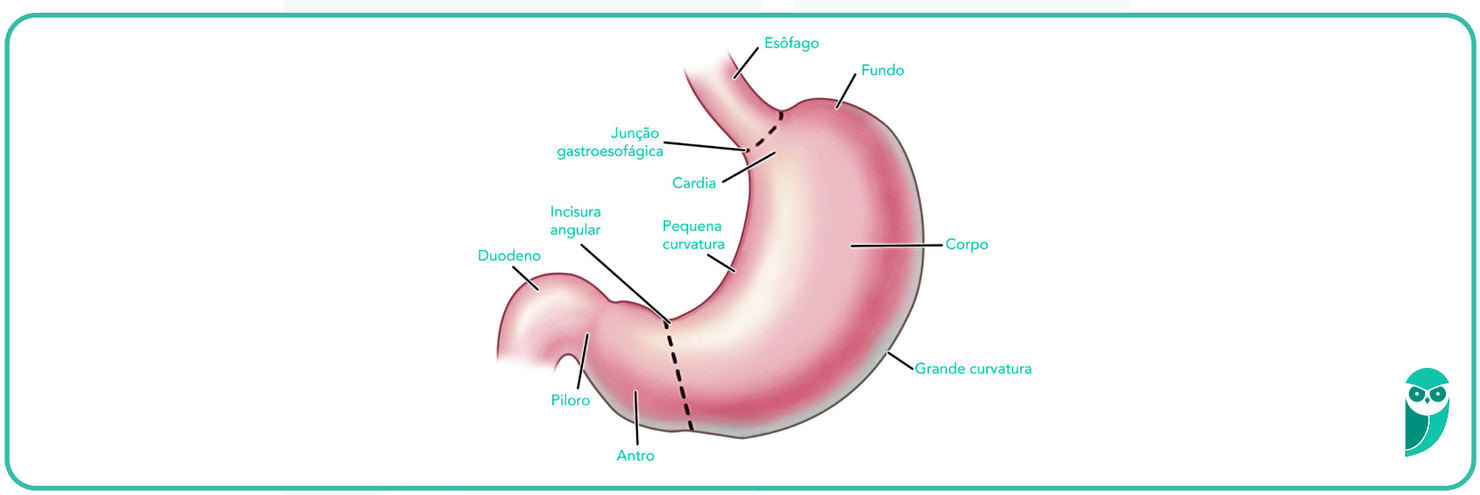
PARA ÚLCERAS GÁSTRICAS

Devemos sempre ressecar a úlcera pelo risco de neoplasia. A extensão da ressecção dependerá do tamanho e da localização da úlcera, podendo ser realizada uma ressecção local em cunha, uma gastrectomia distal (antrectomia ou subtotal) ou até mesmo uma gastrectomia total, com reconstrução a BI, BII ou Y de Roux.



As úlceras gástricas gigantes, definidas com diâmetro ≥ 2 cm, geralmente estão localizadas na curvatura menor e têm uma maior incidência de neoplasia maligna (10%) do que as úlceras menores, têm como tratamento de escolha gastrectomia englobando a úlcera. A vagotomia deve ser associada nas úlceras com hipercloridria, ou seja, tipo II e III de Johnson. Nas úlceras sem hipercloridria (úlceras tipo I e IV) não é necessária a vagotomia.

Para entender o tratamento definitivo da úlcera gástrica, relembraremos a classificação de Johnson. Essa classificação se baseia na localização anatômica e potencial secretor de ácido da úlcera:



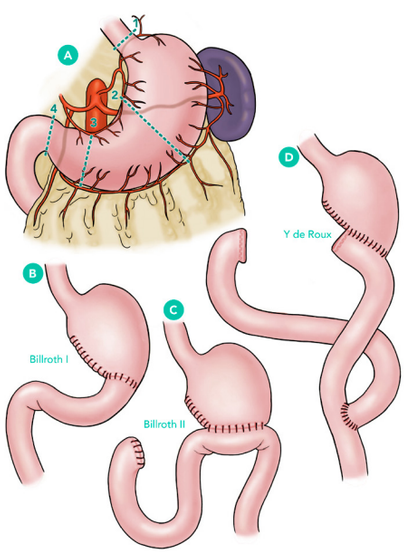
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE JOHNSON - TIPOS DE ÚLCERA GÁSTRICA			
TIPO	**LOCALIZAÇÃO**	**NÍVEL DE ÁCIDO**	**CIRURGIA**
I	Pequena curvatura, incisura angular (60%)	Hipocloridria ou normal	Gastrectomia distal
II	Corpo gástrico com úlcera duodenal (15%)	Hipercloridria	Gastrectomia distal com vagotomia troncular
III	Pré-pilórica (20%)	Hipercloridria	
IV	Parte alta da pequena curvatura, próxima à junção esofagogástrica (< 10%)	Normal	Gastrectomia total ou distal (depende do tamanho e localização)
V	Qualquer local	Normal, induzido por AINE	*Rafia e *patch* de Graham



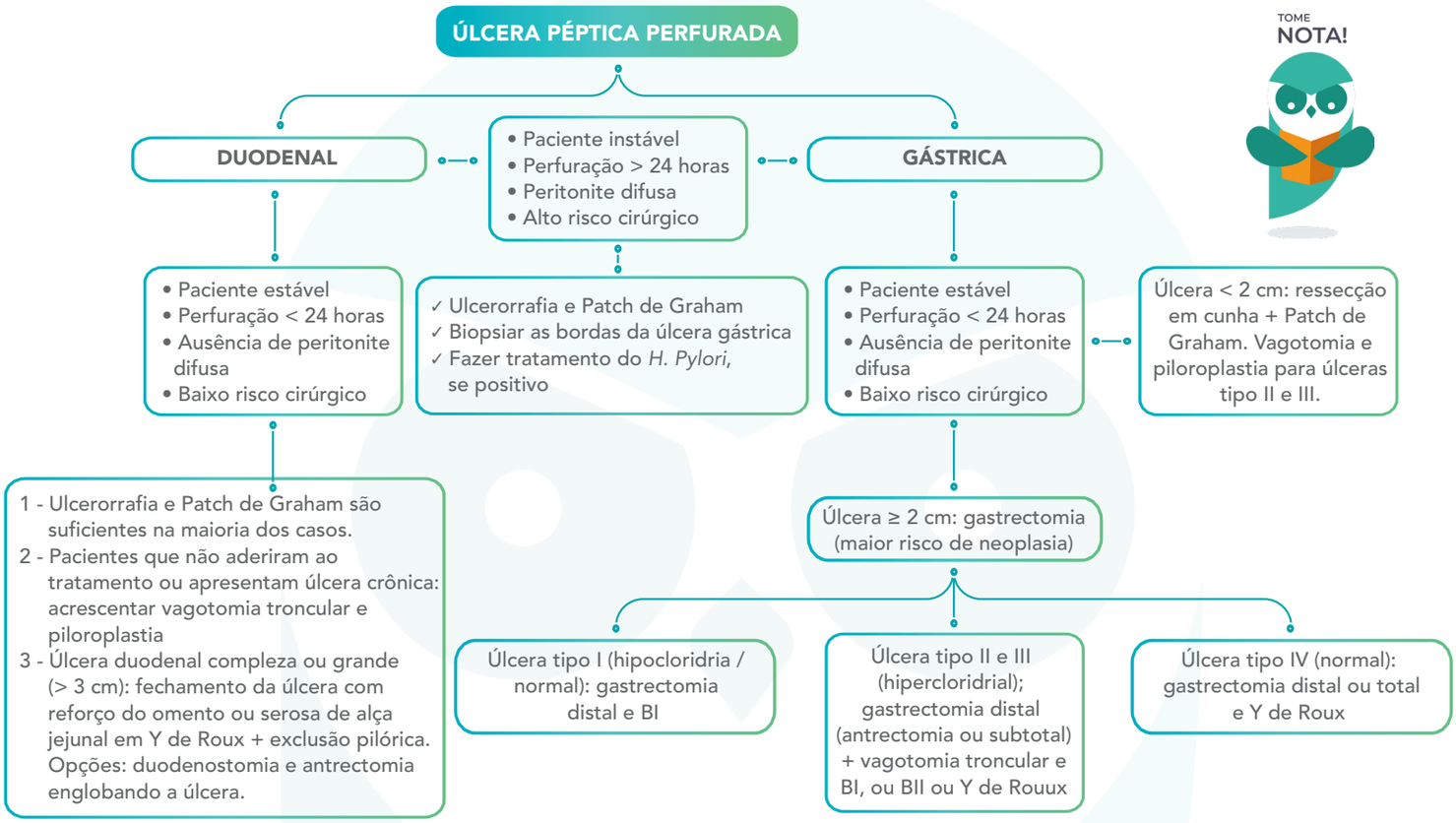
Nas úlceras agudas provocadas por AINE (sem calo ulceroso), a conduta é realizar apenas a rafia e o *patch* de omento.

Agora, vou lhe explicar as reconstruções pós-gastrectomias. Eu sei que, em um primeiro momento, parece ser difícil. Mas veja esta imagem, vai ajudá-lo a compreender melhor:



A: Gastrectomia total: 1-4;
Gastrectomia subtotal: 2-4;
Antrectomia: 3-4
B: Reconstrução a Billroth I (gastroduodenostomia)
C: Billroth II (gastrojejunostomia)
D: Y de Roux

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



RESUMINDO

ABDOME AGUDO PERFURATIVO

Causa mais comum: úlcera péptica perfurada.

Fator de risco: infecção pelo *H. Pylori*, uso de anti-inflamatórios ou AAS.

Local mais comum: parede anterior do bulbo duodenal (1ª porção).

Clínica: dor abdominal súbita, de forte intensidade, taquicardia.

Exame físico: abdome tenso, em tábua, rigidez abdominal e sinais de peritonite difusa, RHA diminuídos.

Diagnóstico: pneumoperitônio à radiografia ou tomografia.

Tratamento: cirúrgico (laparotomia ou laparoscopia).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 OUTRAS CAUSAS DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO

Meu querido aluno, mais de 90% das questões de abdome agudo perfurativo são sobre úlcera péptica perfurada. Mas, a perfuração de qualquer víscera oca, intra ou retroperitoneal, pode levar ao mesmo diagnóstico sindrômico. As manifestações clínicas são semelhantes, com dor abdominal súbita e de forte intensidade, geralmente acompanhada de sinais sistêmicos, como taquicardia, taquipneia, hipotensão, sudorese e sinais de peritonite ao exame físico. O diagnóstico também é confirmado por exames de imagem que demonstrem pneumoperitônio ou retropneumoperitônio e o tratamento, na maioria dos casos, é cirurgia de urgência para reparo da lesão.

Citarei aqui algumas causas de perfuração intestinal.

IATROGENIA (INSTRUMENTAÇÃO/CIRURGIA): endoscopia digestiva alta (especialmente endoscopia rígida), sigmoidoscopia, colonoscopia, colocação de *stent*, escleroterapia endoscópica, intubação nasogástrica, dilatação esofágica e cirurgia (uso excessivo e inadvertido do eletrocautério). Outros procedimentos também podem ser complicados com a perfuração, como drenagem torácica baixa, inserção de cateter de diálise peritoneal, gastrostomia percutânea, paracentese, lavagem peritoneal diagnóstica e drenagem percutânea de abscessos intracavitários.

Nos casos de perfuração colônica após colonoscopia, se o diagnóstico e a indicação cirúrgica forem feitos de forma rápida, não haverá grande contaminação intracavitária, podendo ser realizada apenas sutura primária da lesão, sem necessidade de ressecção intestinal.

PÓS-CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica): a CPRE é um exame invasivo e apresenta complicações, como pancreatite aguda (mais comum), colangite, **perfuração duodenal** e sangramento. O tratamento para todos os tipos de lesão inclui jejum, hidratação endovenosa, passagem de nasogástrica (SNG) e antibióticos endovenosos. Perfurações livres para cavidade abdominal geralmente necessitam de tratamento cirúrgico de urgência. Já perfurações retroperitoneais, sem repercussões sistêmicas, podem ser tratadas clinicamente com as medidas descritas acima. Se o paciente não apresentar boa resposta clínica, ou houver piora, deverá ser operado.

CORPO ESTRANHO: corpos estranhos, como objetos pontiagudos (palitos de dente, pregos), alimentos com superfícies pontiagudas (por exemplo, ossos de galinha, peixe) ou bezoar, podem causar perfuração do trato gastrointestinal. Devemos estar atentos aos pacientes psiquiátricos!

OBSTRUÇÃO: na obstrução intestinal, principalmente na obstrução em alça fechada (dois pontos do intestino encontram-se ocluídos simultaneamente), à medida que há um aumento da pressão intraluminal proximal ao ponto obstrutivo, ocorre isquemia, necrose e consequente perfuração.

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO: processos inflamatórios intracavitários, como apendicite e diverticulite aguda, podem cursar com perfuração e formação de abscessos bloqueados ou peritonite difusa.

ABDOME AGUDO VASCULAR: a presença de isquemia intestinal pode evoluir com perfuração se não tratada adequadamente.

DOENÇA INFECCIOSA: febre tifoide, tuberculose, esquistossomose, citomegalovírus (principalmente imunodeprimidos), podem causar perfuração do intestino delgado.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
4.0 OUTRAS CAUSAS DE PNEUMOPERITÔNIO

PNEUMOPERITÔNIO PÓS-CIRÚRGICO: devemos lembrar que é esperada a presença de pneumoperitônio no pós-operatório de uma cirurgia abdominal. Após 24 horas de uma laparoscopia, aproximadamente 40% dos pacientes terão mais de 2 cm de pneumoperitônio. Já no pós-operatório de uma laparotomia, o pneumoperitônio geralmente pode ser visto em uma radiografia até uma semana, mas o volume deve diminuir gradualmente com o tempo.

PNEUMOPERITÔNIO NÃO CIRÚRGICO: o pneumoperitônio é causado frequentemente por perfurações de vísceras ocas, entretanto, em aproximadamente 10% dos casos, pode estar presente na ausência de perfuração intestinal. Dessa forma, uma etiologia não cirúrgica pode ser a causa do pneumoperitônio. Em pacientes em ventilação mecânica, o pneumoperitônio pode ser causado por pressão positiva contínua nas vias aéreas ou pressão expiratória final positiva (PEEP). Colocação de gastrostomia percutânea endoscópica, paracentese, diálise peritoneal, instrumentação vaginal, abscesso pulmonar e ruptura de alvéolos pulmonares também podem causar pneumoperitônio.

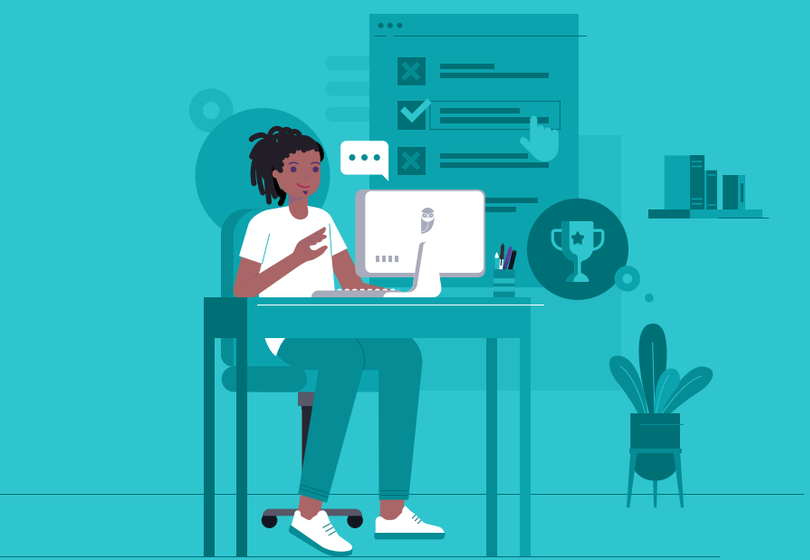
PNEUMOPERITÔNIO IDIOPÁTICO: é uma condição rara e constitui um diagnóstico de exceção. Quando nenhuma causa é encontrada para o achado de um pneumoperitônio, é definido como idiopático.

É válido ressaltar que, frente a um caso de pneumoperitônio identificado nos exames de imagem, ainda devemos manter a clássica conduta de tratamento cirúrgico, independentemente de sua etiologia, sem gerar, para isso, maior morbimortalidade ao paciente, visto que os riscos inerentes à laparotomia exploradora não suplantam os riscos de se deixar uma possível causa de pneumoperitônio sem tratamento.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3sfOti3

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. UpToDate:

   Visão geral da perfuração do trato gastrointestinal.

   Úlcera péptica: manifestações clínicas e diagnóstico.

   Visão geral das complicações da úlcera péptica.

   Tratamento cirúrgico da úlcera péptica.

   Vagotomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, com este resumo, você conseguirá responder a maioria das questões sobre abdome agudo perfurativo!

Coloquei aqui as principais patologias que podem cursar com perfuração intestinal. Mas, dê uma atenção especial à perfuração por úlcera péptica, pois essa é a principal causa de abdome agudo perfurativo e por isso a mais cobrada nas provas.

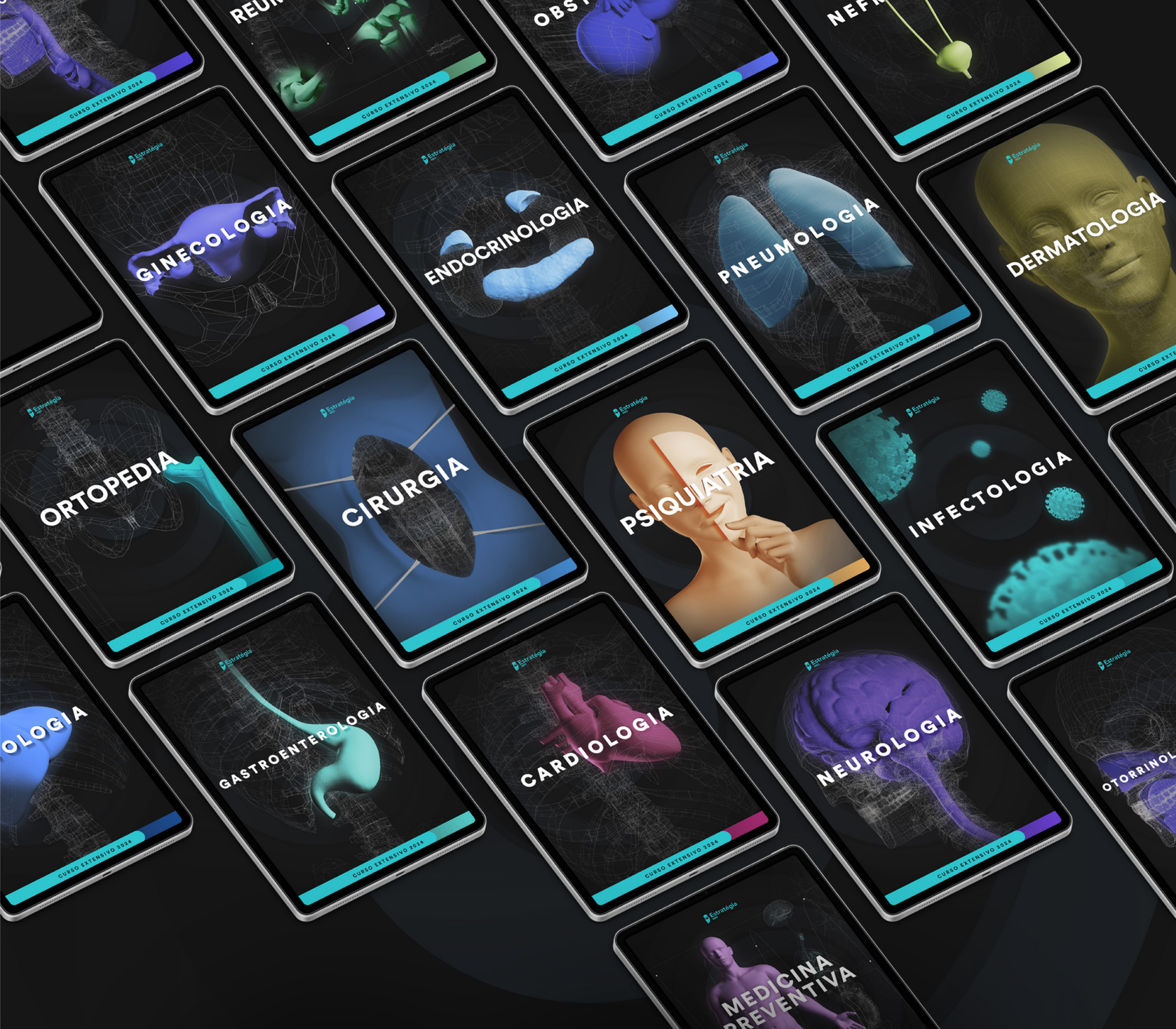
Lembre-se de que estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! E fique com Deus!!!

Abraços,

Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina